

Онлайн-запись к врачам: что мы выяснили

Медицинский центр «Лотос». Разбор ваших ответов, сентябрь 2026 года. Документ отвечает на три вопроса: что уже понятно, что придётся изменить в замысле и что мы предлагаем делать дальше.

Коротко

Ваши ответы сняли главную неопределённость. Расписание ведётся в программе, а не на бумаге. Собирать паспорт, СНИЛС и ИНН на сайте вы согласились не надо — это снимает с проекта самую тяжёлую часть обязанностей по защите персональных данных. Юрист у вас есть. Всё это хорошие новости.

Главный вывод обследования неожиданный. Самая дорогая часть проекта — не поиск врача и не расписание, а одно-единственное правило: «время держится за пациентом, а деньги он приносит до 17:00». Чтобы система сама снимала неоплаченные записи, она должна сама узнавать о каждом платеже. Сегодня вы узнаете об оплате из СМС, а все предоплаты одинаковые — 400 рублей. Понять по такому сообщению, кто именно заплатил, невозможно ни человеку, ни программе.

Если на сайте оставить только оплату сразу, проект становится примерно втрое короче и дешевле. Бронь до 17:00 и наличные при этом никуда не исчезают — они остаются по телефону и в регистратуре, ровно как сегодня.

И есть четыре вещи, которые мы не сможем сделать так, как задумано, потому что это противоречит закону. Мы обязаны сказать о них до начала работ, а не после.

Пять вопросов, без которых мы не назовём ни срок, ни цену

Остальные вопросы можно решать по ходу. Эти пять — нет: от каждого зависит, какой это проект по деньгам и по времени.

1. Что за программа у вас стоит.

Попросите администратора открыть 1С, нажать «О программе» и прислать снимок экрана. Там видно точное название и версию. Под словами «1С Медицина» скрывается около восьми разных программ с очень разными возможностями. Заодно: кто её обслуживает и есть ли договор сопровождения.

2. Есть ли у вас зарегистрированная касса и какой у неё оператор фискальных данных.

На этот вопрос в прошлый раз ответа не было — вы ответили только «чек не выдаём». Раз вы принимаете наличные, касса у вас почти наверняка есть, и тогда задача совсем другая и намного дешевле.

3. Куда приходят деньги по ссылке Челиндбанка.

На расчётный счёт клиники или на чью-то личную карту? Это определяет, можно ли вообще строить автоматическую оплату. И пришлите, пожалуйста, саму ссылку или снимок страницы оплаты — мы её ещё не видели.

4. Сколько пациентов вы принимаете в день и сколько из них не приходит.

Хотя бы примерно, за последний месяц. Предоплата вводится против неявок, но мы не знаем, сколько их. Без этой цифры нельзя показать, что проект окупается, а после запуска снять её уже не получится.

5. Согласны ли вы, что на сайте будет только оплата сразу.

Не оплатил — записи нет, время свободно. Бронь до 17:00 и наличные остаются по телефону и в регистратуре. Это решение сокращает проект примерно втрое, и принять его можете только вы.

Четыре вещи, которые придётся изменить в замысле

Это не наши предпочтения и не осторожность. Каждый пункт мы проверили по текстам законов, ссылки приведены. Решать вам, но делать вид, что мы этого не заметили, мы не можем.

1. Предоплату нельзя принимать без кассового чека

Закон о кассовой технике прямо относит получение аванса к расчётам, при которых нужен чек. Медицинских организаций в списке исключений нет. Чеков на одну запись получается даже не один, а два: на предоплату и на зачёт этой предоплаты в день приёма. При отмене с возвратом нужен третий.

Штраф для юридического лица — от трёх четвертей до полной суммы расчёта, но не менее 30 000 рублей. То есть за предоплату в 400 рублей штраф составит 30 000. Отдельно отметим: в феврале 2026 года законопроект о повышении этого минимума до 150 000 рублей прошёл первое чтение. Он ещё не принят, но направление понятно.

Важно, что выход есть и он недорогой. Если подать чеки коррекции самостоятельно, до того как налоговая обнаружит нарушение сама, от ответственности освобождают. Это прямо записано в примечании к статье о штрафе. Сделать это нужно до запуска сайта, а не после: сайт превращает разовую небрежность в систему с цифровым следом.

2. «Предоплата не возвращается» — условие недействительное

Вы это и сами написали в ответе, и написали верно. Потребитель вправе отказаться от услуги в любой момент, возместив исполнителю только фактически понесённые расходы. Условие в договоре, которое это право ограничивает, ничтожно — то есть не работает, даже если пациент под ним подписался.

Доказать, что несостоявшийся приём стоил клинике ровно 400 рублей, на практике почти невозможно. Поэтому текст в оферте должен звучать иначе, а сами 400 рублей не стоит заранее считать доходом. Штраф за включение ущемляющего условия в договор невелик — для юридического лица от 10 до 20 тысяч рублей. Дороже другое: именно такой отказ вернуть деньги обычно и становится поводом для жалобы, а жалоба приводит проверку уже по кассовому вопросу.

3. Программу нельзя научить запрещать отмену

Пожелание «программа не должна давать делать отмену за 24 часа» выполнить нельзя: право отказаться от услуги у пациента есть всегда. Кнопка отмены будет работать в любой момент, включая последние сутки.

Дисциплину это не отменяет, просто держится она другим. Пациент видит на экране, что при поздней отмене предоплата удерживается, подтверждает это отдельной галочкой, а система считает и показывает вам поздние отмены и неявки по каждому человеку. Работает это не хуже запрета, а спорить с этим никто не сможет.

4. «При неявке предоплата отдаётся врачу» придётся перестроить

Здесь три проблемы сразу. Пациент вправе потребовать деньги назад и после неявки — а они уже отданы. В учёте эти 400 рублей остаются обязательством клиники, пока не истёк срок возврата, и передавать их до этого некорректно. И главное: у неявки появляется тот, кому она выгодна.

Предлагаемое решение простое: деньги остаются в клинике, а врач получает премию из фонда оплаты труда. Сумма для врача та же, а учёт сходится. Это решение ваше и вашего бухгалтера, но заложить его надо до запуска.

Отдельно, вне связи с онлайн-записью. С 1 сентября 2026 года действуют новые Правила предоставления платных медицинских услуг, они заменили прежние. Изменились требования к договору, к тому, что обязано быть на сайте, и появилась возможность заключать договор дистанционно. Плюс с сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных должно быть отдельным документом: одна галочка «согласен со всем» больше не годится. И уведомление в Роскомнадзор об обработке данных теперь обязательно для всех, прежние исключения отменены, штраф за его отсутствие для юридического лица — до 300 000 рублей. Это стоит поручить юристу независимо от того, будет у вас онлайн-запись или нет.

Что мы предлагаем

Вы просили вести вас, поэтому говорим прямо, а не перечисляем варианты.

Не стоит писать систему записи с нуля. Для клиники на 12 врачей это примерно четыре-шесть месяцев работы и несколько сотен тысяч рублей сверх того, что вы заплатите за готовый сервис, плюс постоянная зависимость от одного подрядчика. Разумнее взять готовый сервис записи, в котором оплата и касса уже сделаны и проверены, а нашу работу свести к странице на вашем сайте, настройке и тем надстройкам, которых в готовом сервисе нет.

Проверять будем в таком порядке:

Шаг	Что делаем	Если получилось
Сначала	Проверяем, подключается ли к вашей 1С готовый модуль записи. Тогда расписание остаётся там, где оно есть сейчас, и двойного ввода не появляется вообще.	Самый дешёвый исход. Порядок расходов — несколько сотен рублей в месяц.
Если нет	Берём готовую медицинскую систему записи и выделяем сайту собственную долю времени у каждого врача. Регистратура это время не трогает физически.	Одно время нельзя продать дважды по устройству системы, а не по договорённости. Цена — тысячи рублей в месяц.
В любом случае	Страница записи на вашем сайте, обязательные разделы по новым Правилам, подключение оплаты с кассой, напоминания, обучение администраторов.	Это и есть наша работа.

Запускаться предлагаем тихо: два-три врача, месяц работы, и только потом остальные. Цифры, по которым вы сами признаете пилот удачным, надо записать заранее — иначе через месяц разговор превратится в «давайте ещё посмотрим».

Своя разработка остаётся честной альтернативой ровно в одном случае: если вы не откажетесь от правила «бронь висит, деньги до 17:00» на сайте. Тогда это другой проект, другой срок и другая смета, и обсуждать его надо до договора, а не после.

Решения, которые можете принять только вы

Решение	Почему это ваше
На сайте — только оплата сразу. Бронь до 17:00 и наличные остаются по телефону и в регистратуре.	От этого зависит, полуторамесячный это проект или полугодовой.
Кнопка отмены работает всегда, слова «предоплата не возвращается» уходят из всех текстов.	Иначе условие всё равно не будет работать, но принесёт жалобы.
Подать чеки коррекции по уже принятым предоплатам до запуска сайта.	Пока налоговая не обнаружила сама — без штрафа. Это расходы и обязанность клиники.
При неявке деньги остаются в клинике, врач получает премию.	Решение ваше и бухгалтера, техника его не заменит.
Дать доступ к 1С и назвать обслуживающего партнёра.	От этого зависит, будет двойной ввод у администраторов или нет.
Согласие на то, что данные пациентов будут храниться у стороннего сервиса.	Оператором данных остаётесь вы. Нужен договор-поручение и проверка, что серверы в России.

Решение	Почему это ваше
Правила для врачей: приём с оплаченными записями врач сам не снимает, график фиксируется заранее.	Иначе онлайн-запись потеряет доверие пациентов в первый же месяц.
Кто участвует в пилоте и по каким цифрам вы признаете его удачным.	Без записанных заранее порогов пилот не закончится никогда.
Домен, хостинг и доступы: на каких условиях в проекте участвует нынешний разработчик сайта.	Это организационный вопрос, и он способен остановить запуск в последний день.

Остальные вопросы

Их можно отвечать не сразу и по частям. Но чем раньше ответы, тем меньше переделок.

Деньги

6. Предоплату берёте со всех пациентов или только по некоторым услугам? С какого времени так работаете?
7. Эти 400 рублей проходят через кассу и видны бухгалтеру?
8. Остаток стоимости приёма можно оплатить картой на ресепшене, или только наличными? Есть ли терминал?
9. Пациент внёс предоплату наличными и отменил запись — как именно вы возвращаете ему деньги?
10. Сколько вы храните предоплату человека, который не пришёл и денег не требует? Что с ней происходит дальше?

Приём и услуги

11. Бывает, что за один приход человек идёт и на консультацию, и на УЗИ к тому же врачу? Как это записываете и сколько берёте предоплаты?
12. Есть ли услуги, к которым надо готовиться заранее: натошак, с наполненным мочевым пузырём, отменить лекарства? Кто предупреждает сейчас?
13. Кто из врачей принимает детей и с какого возраста? По всем услугам или по некоторым?
14. Принимаете ли по ОМС, ДМС, договорам с предприятиями, делаете ли медосмотры? Этим пациентам тоже записываться через сайт?
15. Цена одинаковая для всех, или повторный приём дешевле, есть скидки и льготные категории?

Как устроена работа

16. В какие часы и дни работает клиника? Есть ли вторая смена, как работаете в субботу и в праздники?

17. Сколько звонков в день принимает регистратура, сколько остаётся без ответа, сколько администраторов в смене?
18. Через сколько минут опоздания вы считаете, что пациент не пришёл?
19. Есть ли вы уже на ПроДокторов, СберЗдоровье, 2ГИС, Яндексe? Записываются ли к вам через мессенджеры?
20. Сколько времени уходит у администратора, чтобы завести карту и подписать документы первичному пациенту? Хватает ли 10 минут?

Люди

21. Ваши врачи в штате или совместители с основной работой в другом месте? Оклад или процент от приёма?
22. Врачи знают про планы и согласны, чтобы их фамилии и расписание были видны всем, а график фиксировался заранее?
23. Если вы и владелец видите вопрос по-разному — чьё слово последнее и кто подписывает договор?
24. Юрист штатный или приходящий? За сколько дней он подготовит оферту, политику и согласия, и кто оплачивает его работу?

Рамка проекта

25. Сколько человек в месяц заходит на ваш сайт сейчас? Если стоит счётчик посещений — пришлите снимок экрана.
26. Какой у вас средний чек за приём? Это нужно, чтобы честно посчитать окупаемость.
27. Какую сумму и какой срок вы держите в голове? Варианты отличаются в несколько раз, и без рамки мы не сможем посоветовать.

О точности того, что здесь написано

Правовые выводы мы проверили по действующим текстам законов, и по ним готовы отвечать. Но юрист клиники обязан сверить их перед подписанием договора — это его работа, а не наша.

А вот сроки, цены и расчёты окупаемости в этом документе пока предварительные. У нас нет от вас ни одной цифры: ни числа приёмов, ни доли неявок, ни среднего чека, ни посещаемости сайта. Всё, что мы считали, посчитано по отраслевым средним. Тарифы готовых сервисов мы тоже брали из открытых источников и не подтверждали у поставщиков. Как только придут ответы на пять вопросов выше, оценка станет настоящей — с ней и надо будет идти к владельцу.